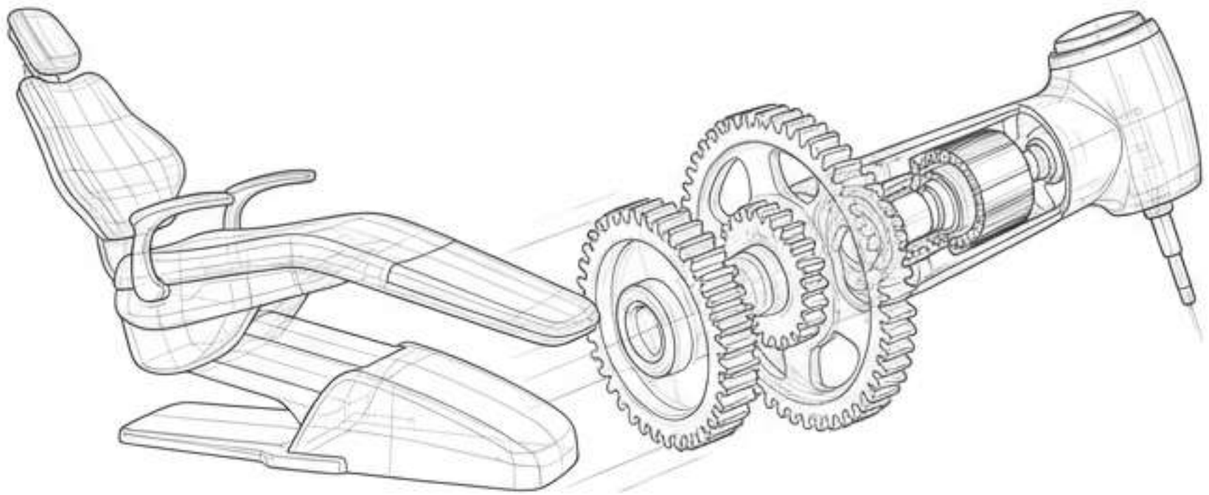
Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
Université des Sciences de la Santé
Faculté de Médecine Dentaire
EHS MAOUCHE MOHAND AMOKRANE Ex CNMS
Service Pathologie et Chirurgie Buccales



Cabinet Dentaire & Dispositifs Chirurgicaux: L'Atlas Clinique

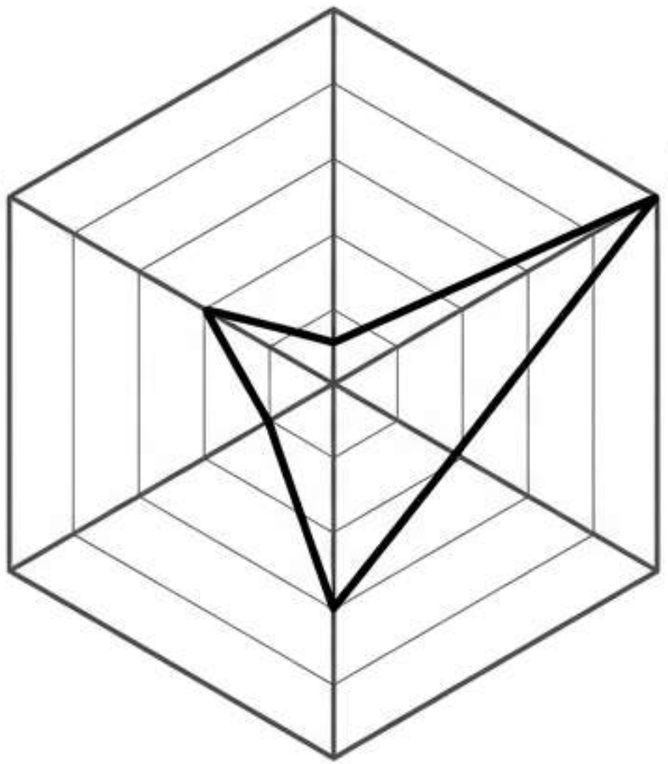
Cours de Pathologie Bucco-Dentaire - 2ème Année (2025-2026)

Dr. SAIDI.K
EHS MAOUCHE MOHAND AMOKRANE Ex CNMS
Service Pathologie et Chirurgie Buccales

Document strict: Basé exclusivement sur le support de cours officiel. 100% de couverture de contenu certifiée.

Dentist Web

Stratégie d'Examen & Analyse des QCM



Historique des QCM (2018-2024) cible fortement :
- **Instrumentation Dynamique**: Vitesses de rotation, sens de rotation, contre-indications osseuses [Ref: Q3, Q7, Q13]
- **Instrumentation Statique**: Fonction exacte de la Pince Gouge [Ref: Q5]
- **Équipement du Fauteuil**: Systèmes d'aspiration obligatoires [Ref: Q8]

Cibles à haut risque (2025/2026) :
- **Nomenclature Chiffrée**: Numérotation des manches et lames de bistouri, volumes exacts d'anesthésie (1,7 / 1,8mL) [Predicted - High probability matching]
- **Codes Couleurs**: La matrice des bagues de contre-angles et leurs rapports [Predicted - Classic MCQ trap]

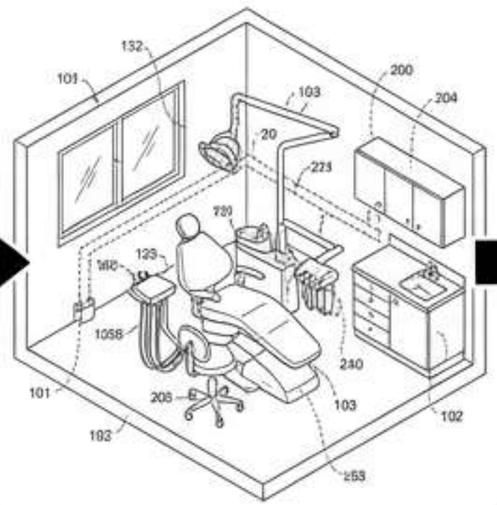
Règle d'Autorité Suprême : Ce document s'en tient strictement aux données du PDF. Les divergences rencontrées dans d'anciennes questions (ex: vitesse turbine 420k, conditions d'ouverture) sont ignorées au profit du texte officiel.

Dentist Web

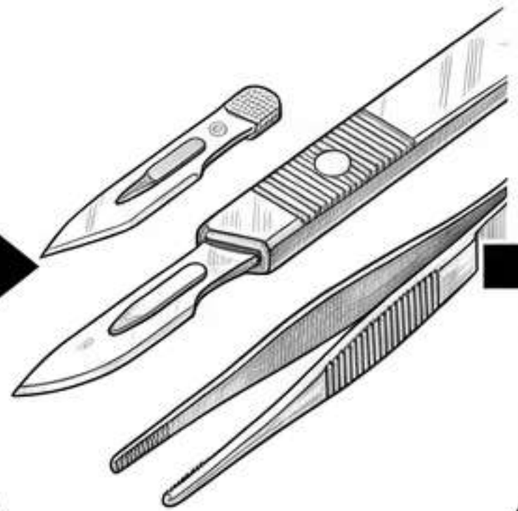
Architecture du Cours: Du Macro au Micro

MACRO

MÉSO



MICRO I



MICRO II

1. Organisation du Cabinet

(Principes, Pièces, Zones Fonctionnelles)

2. Équipement Spécifique

(Poste Opératoire, Infrastructures, Hygiène)

3. Instrumentation Statique

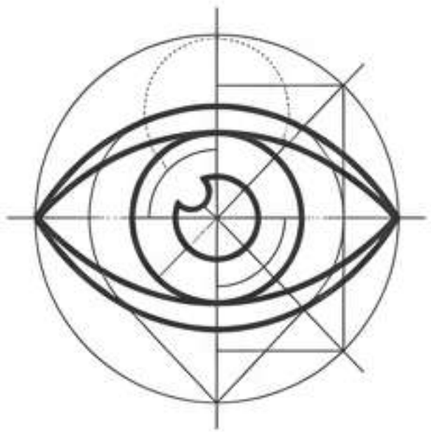
(Examen, Anesthésie, Extraction, Chirurgie)

4. Instrumentation Dynamique

(Turbines, Micromoteurs, Contre-angles)

Dentist Web

Principes de Création : Vision et Structuration



La Philosophie du Cabinet :

- Reflet de la vision du praticien.
- Si fonctionnel, esthétique et confortable -> exercice productif.
- Il est la « carte de visite du praticien ».
- Rigueur dans la planification et conception est essentielle.

Pré-requis de Création

- Type d'exercice désiré (omnipratique, chirurgie, pédodontie, implantologie...)
- Surface disponible
- Aspects règlementaires

	Division Bipartite du Cabinet	
Plan Médical	1. Zone clinique et paraclinique	2. Zone administrative, d'accueil, repos
Plan Fonctionnel	1. Zone active et semi-active	2. Zone semi-active et passive

Dentist Web

Inventaire Architectural : Les Pièces du Cabinet

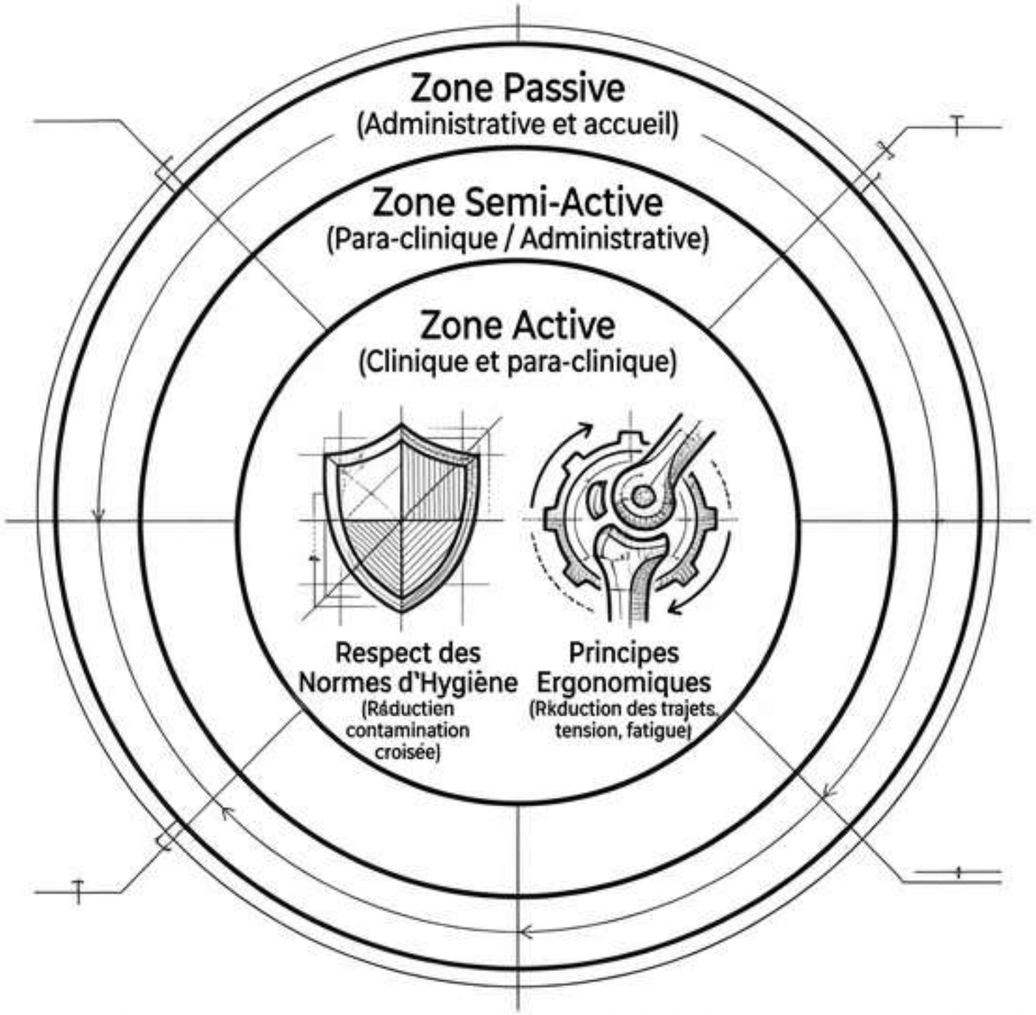
Installation Minimale Obligatoire ★	Obligatoire (Si personnel) 👤	Facultatives (Selon moyens) ✚
• Accueil, secrétariat • Salle d'attente • Salle de soins • Salle de stérilisation • Zone de stockage DASRI • Local technique • Sanitaires	• Sanitaires (distincts) • Salle de repos	• Bureau privé • Salle distincte compresseur/aspiration • Salle de radiographie • Salle de chirurgie (indispensable pour implantologie/paro) • Laboratoire de prothèse

Règle Architecturale : Établir une circulation à « sens unique » pour le patient, les dispositifs médicaux, et leur décontamination-stérilisation.

Dentist Web

The Clinical Blueprint & Technical Atlas

Détermination des Zones Fonctionnelles



Cette séparation physique de l'espace dentaire concilie le double objectif fondamental du cabinet : l'hygiène stricte et l'ergonomie optimale pour le praticien, l'assistante et le patient.

Dentist Web

Clinical Blueprint & Technical Atlas

La Zone Active : L'Unité de Production

Salle de soins

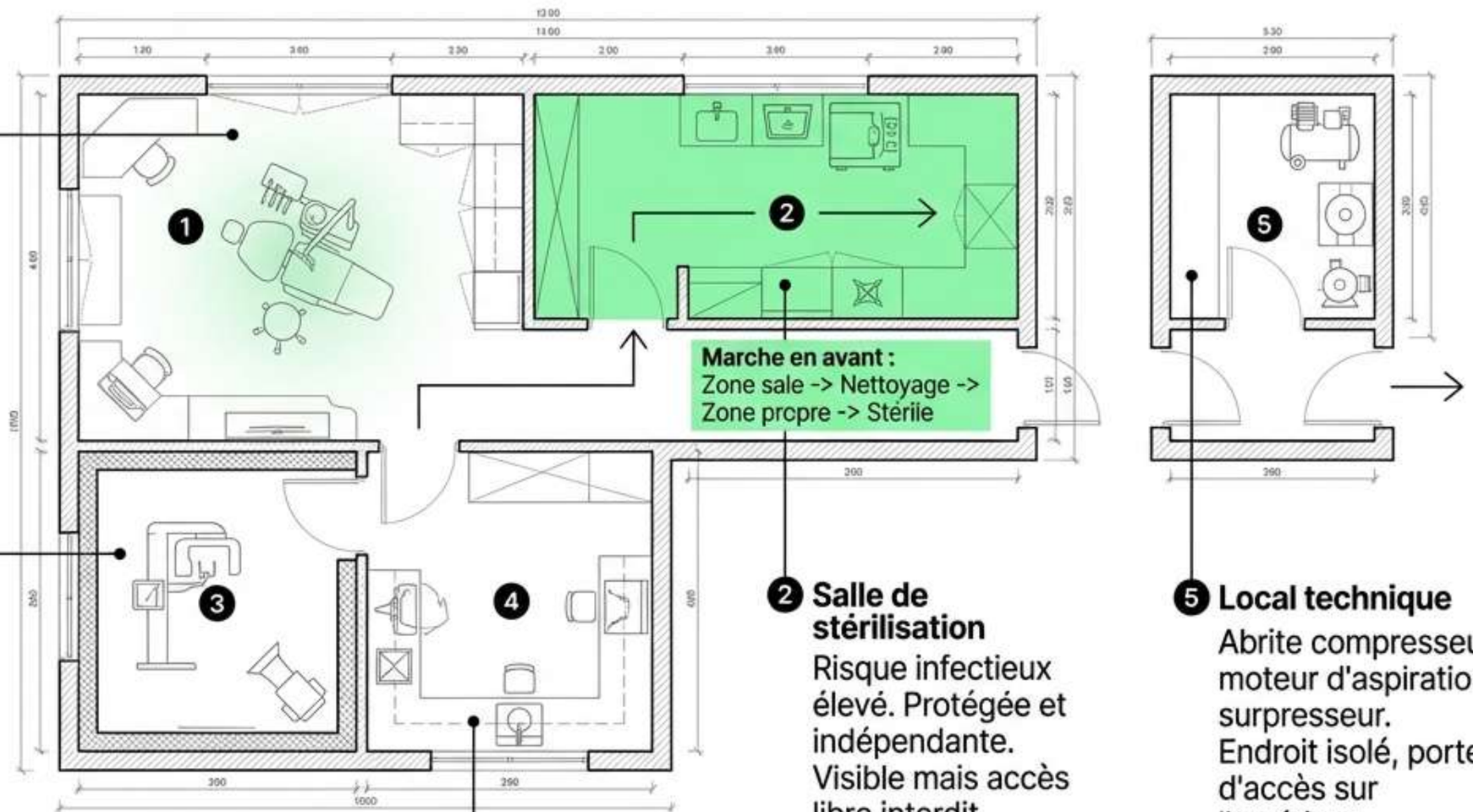
Centre névralgique incontournable.
Implantation du mobilier cruciale pour l'ergonomie.
Pour legonomie.
Flexibilité requise face à l'évolution.

Salle de radiographie

Panoramique / Cone beam.
Murs = rôle d'écran contre rayonnements.

Laboratoire de prothèse

Exécution des étapes de laboratoire.



2 Salle de stérilisation

Risque infectieux élevé. Protégée et indépendante.
Visible mais accès libre interdit.

5 Local technique

Abrite compresseur, moteur d'aspiration, surpresseur.
Endroit isolé, porte d'accès sur l'extérieur.

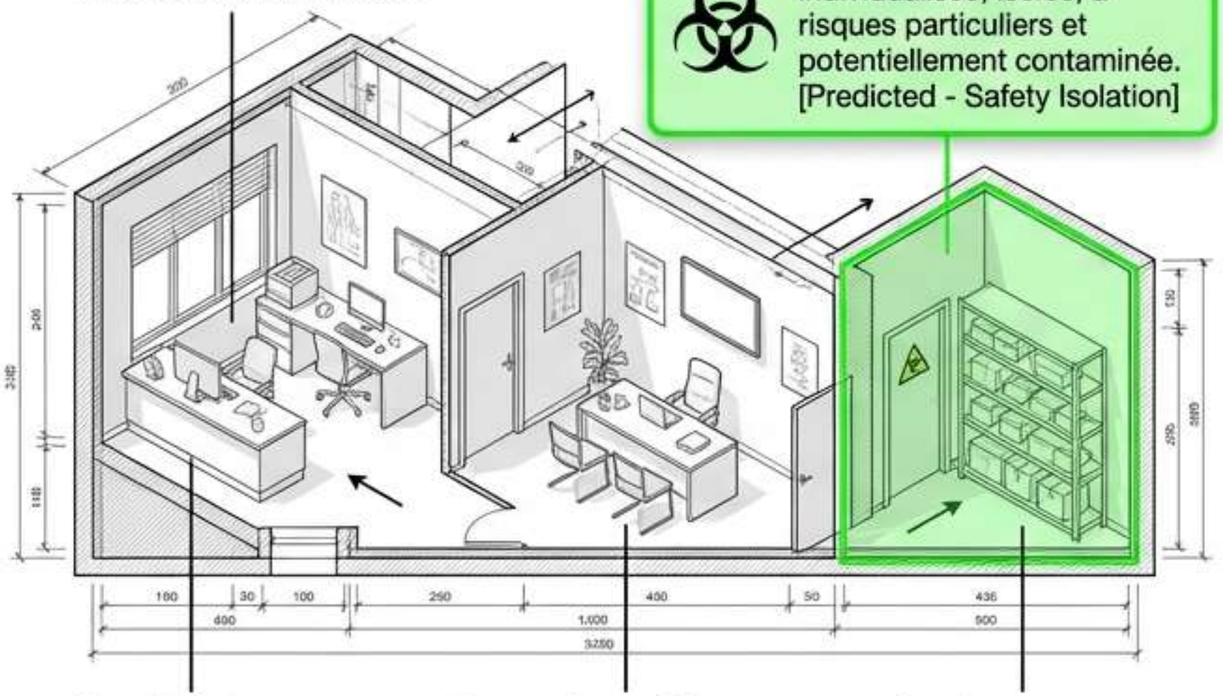
Dentist Web

Zones Semi-Active & Passive

Zone Semi-Active (Activité moins intense, pas de soins)

Secrétariat : Lieu d'accueil/info. Reflète l'image du cabinet.

Stockage DASRI : Pièce individualisée, isolée, á risques particuliers et potentiellement contaminée. [Predicted - Safety Isolation]



Secrétariat : Lieu d'accueil/info. Reflète l'image du cabinet.

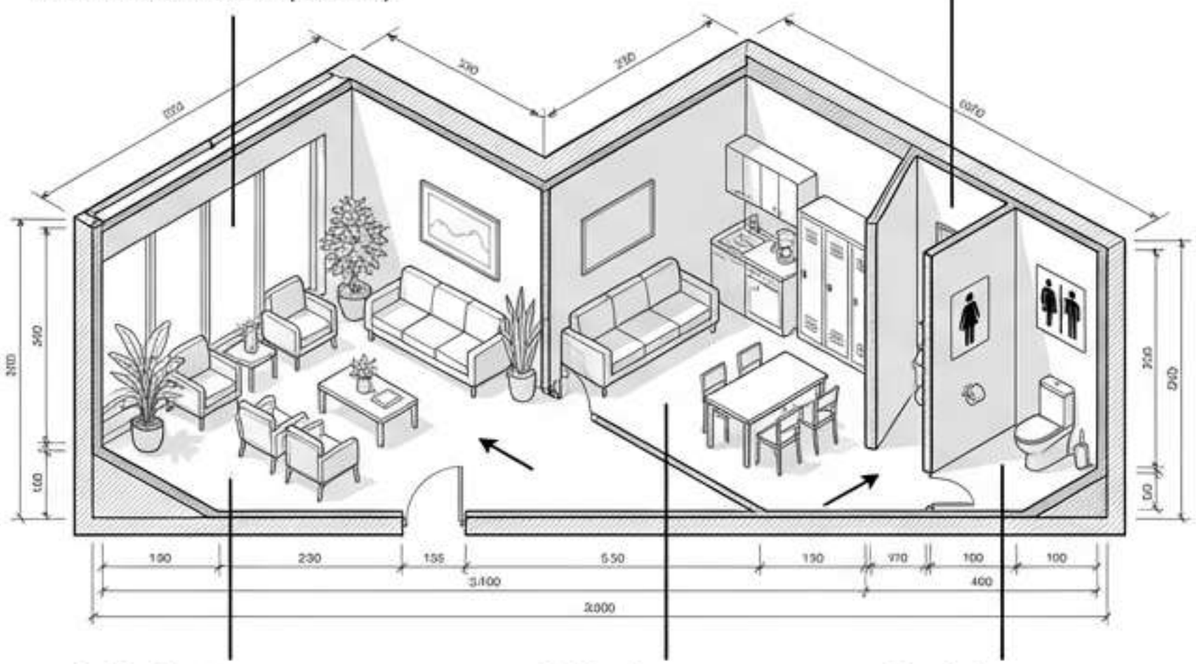
Bureau du praticien : Explications plans de traitement. Sas d'accueil ou salle propre.

Stockage propres : Désencombre salles opératoires.

Zone Passive (Fréquence faible, repos)

Salle d'attente : Seconde impression. Calme, aérée, non cloisonnée (contact visuel avec accueil préféré).

Sanitaires : Distincts pour patients et personnel.



Salle d'attente : Seconde impression. Calme, aérée, non cloisonnée (contact visuel avec accueil préféré).

Salle de repos : Détente du personnel à l'abri des patients, vestiaire.

Sanitaires : Distincts pour patients et personnel.

Dentist Web

Équipement Spécifique : Le Poste Opératoire

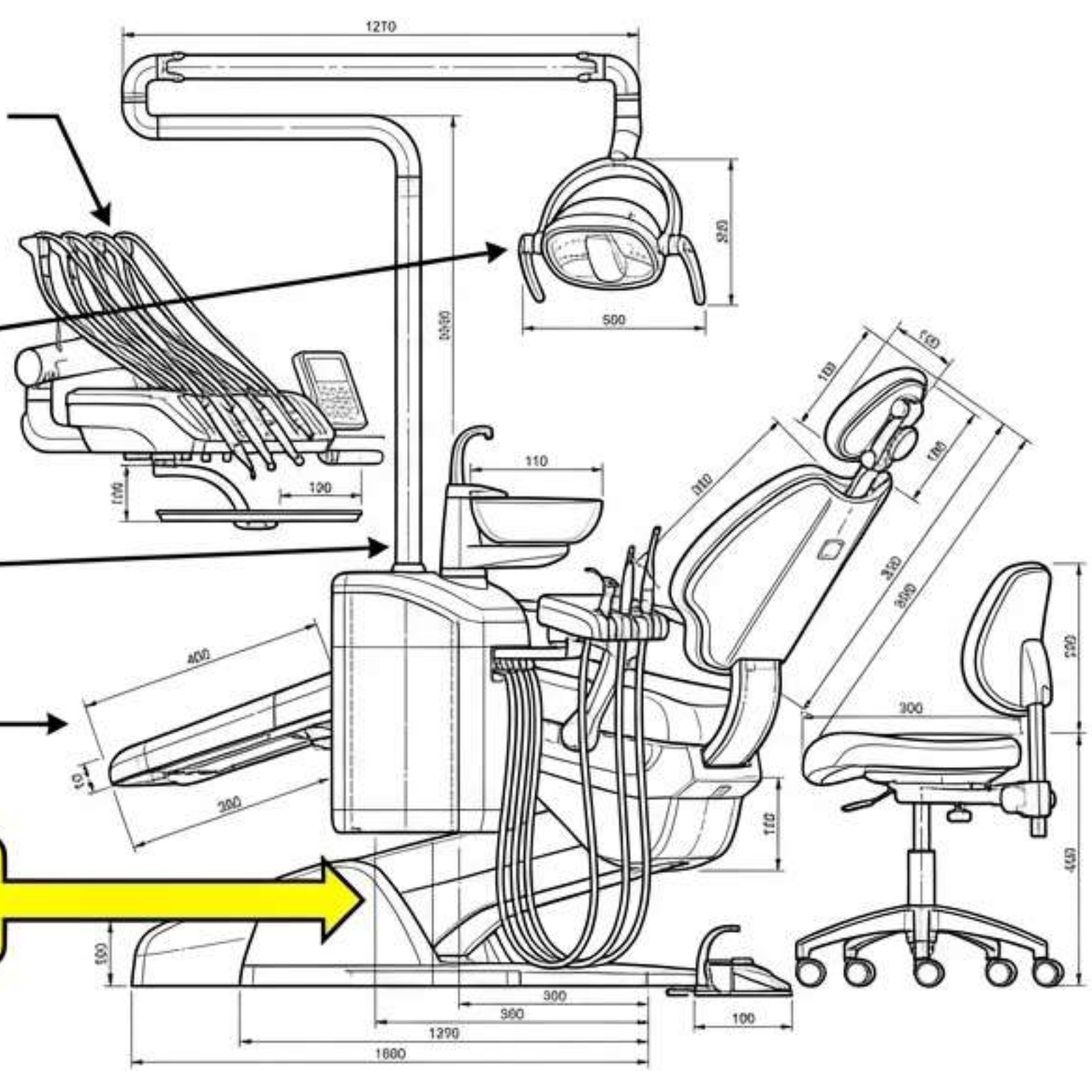
Bras 1 : Supporte le plateau (porte-instruments, micro-moteurs, soufflette air/eau).

Bras 2 : Supporte le Scialytique (éclairage médical).

Crachoir : Toujours placé sur le côté gauche du patient.

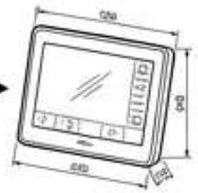
Siège du praticien.

Système d'aspiration
[Ref: Q8 - Toujours équipé]



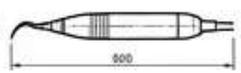
Équipements Modernes Intégrés

Écran de commande →

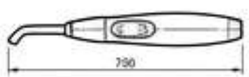


Pédale de commande et d'actionnement →

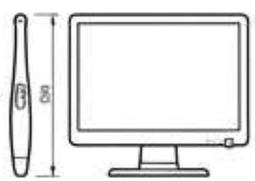
Détartreur à ultrasons →



Lampe à polymériser →

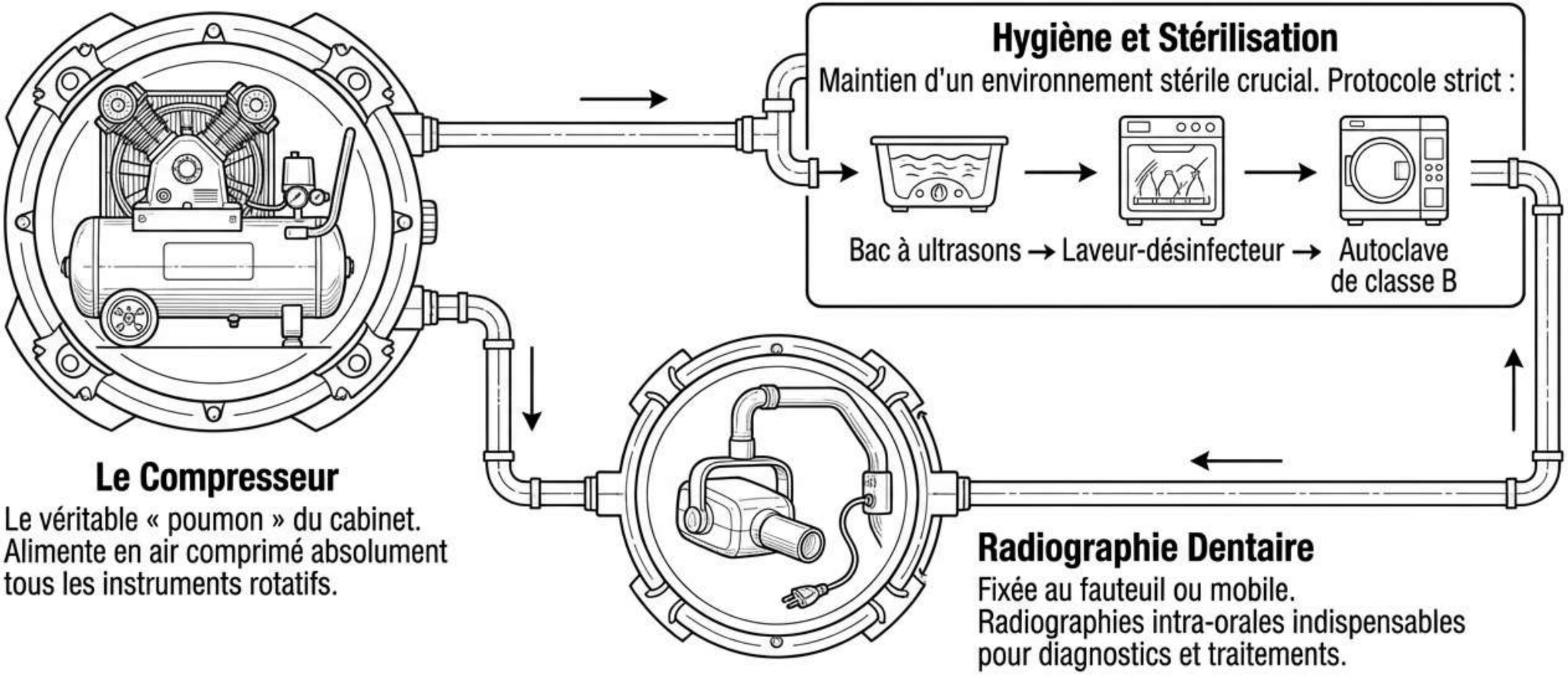


Caméra intra-buccale mobile et écran →



Dentist Web

Infrastructures Vitales : Énergie, Stérilisation et Imagerie



Dentist Web

Clinical Blueprint & Technical Atlas

Instrumentation Statique I : Instruments d'Examen

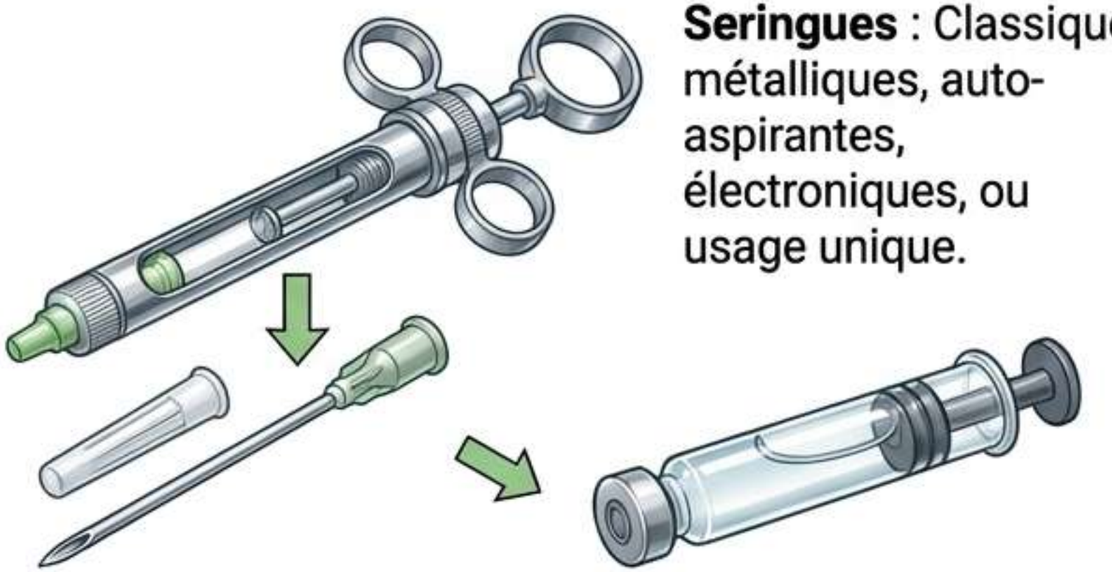
Fonctionnent sans source d'énergie. Base de toutes les interventions.

	Miroirs dentaires : Vision indirecte et écartement des joues et lèvres.
	Sondes exploratrices : Extrémité POINTUE. Détection des caries et irrégularités (restaurations défectueuses).
	Précelles : Manipulation précise de petits objets/matériaux, ergonomie optimisée.
	Sondes parodontales graduées : Évaluation de la santé parodontale (sondage). Tige graduée à bout ÉMOUSSÉ.

Dentist Web

Instrumentation Statique II : Anesthésie et Extraction

Anesthésie



Seringues : Classiques métalliques, auto-aspirantes, électroniques, ou usage unique.

Aiguilles : Toujours bi-pointes, stériles et à usage unique. Choix par calibre/longueur. [Predicted]

Solutions : Cartouches en verre. Volume strict de 1,7 ou 1,8mL. [Predicted - High Risk MCQ]

Extraction Dentaire

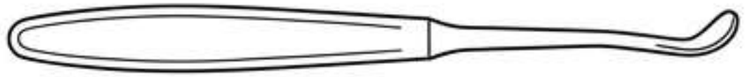
Mécanique d'extraction (Choix selon localisation/nature) :

1. **Syndesmotomes** : Coupent la sertissure gingivale (évite déchirures).
2. **Élévateurs** : Servent à mobiliser la dent après syndesmotomie.
3. **Daviers** : Pinces pour saisir très solidement la dent et la retirer de son alvéole.

Dentist Web

Instrumentation Statique III : Curetage et Incision

Curetage:

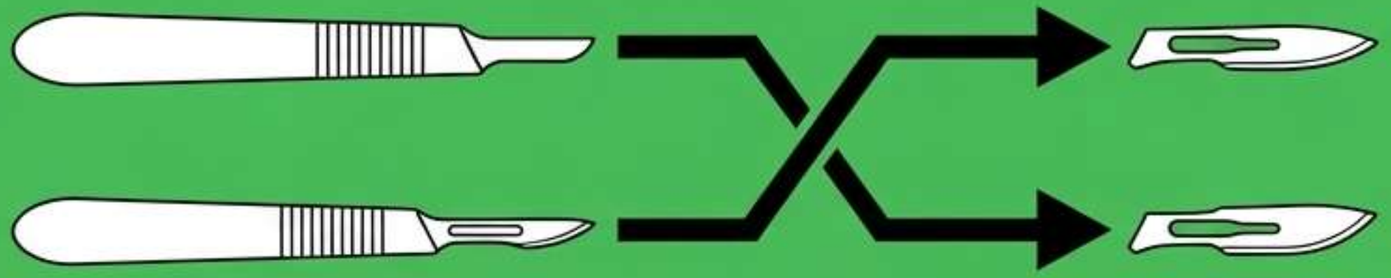


Curettes : Débridement des tissus de granulation/infectieux.
(Ex: Lucas, Hemingway, Mitter…)

Incision - Règle des Manches:

Lames de bistouri : Premier temps chirurgical (sectionner tissus mous).
Porte-lames plats, ronds, ou angulés.
Règle absolue : **[Predicted - Classification Match]**

Manche n°4



Lames à partir de 20

Manche n°3

Lames à partir de 10

Manipulation Tissulaire:

Décolleurs :
Partie active MOUSSE.
Simple (Williger) ou double (Molt).
Élévation délicate.

Écarteurs :
Visibilité du site.
Facilite accès, incisions et sutures.
Formes selon localisation.

Dentist Web

Clinical Blueprint & Technical Atlas

Instrumentation Statique IV : Suture et Instruments Divers

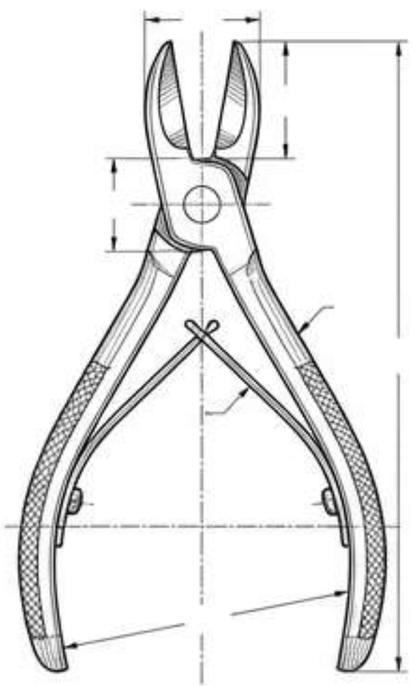
Suture:

- **Porte-aiguilles :** Pinces à crémaillère, extrémité mousse avec striations croisées.
- **Fils de suture :** Résorbables/non-résorbables. Aiguille sertie ronde/triangulaire. Différents calibres.
- **Précelles à tissu :** Mors crantés, préhension atraumatique du lambeau pour passage d'aiguille.
- **Ciseaux à suture :** Fins et pointus, affûtés pour couper précisément sans déchiqueter.

Instruments Divers:

Pinces hémostatiques : Clamper les vaisseaux, contrôler hémorragies.

Râpes à os : Doubles, râpe à larges pans, forme légèrement concave.



Pinces gouge : Manches articulés avec ressort. Mors symétriques tranchants. Utilisée pour régulariser les bords des plaies osseuses et éliminer les esquilles/rebords alvéolaires fins. [Ref: Q5]

Dentist Web

Instrumentation Dynamique I : Énergie et Générateurs

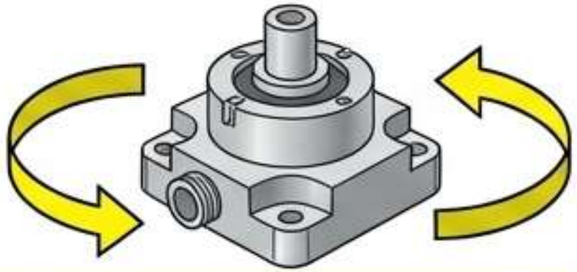
Actionnés par énergie (électrique/pneumatique) via cordons multicanalaires conduisant air/eau.

Turbines (Pneumatiques)

VITESSE MAX: 400 000 rotations/mn.
INDICATION: Réservée au travail sur l'émail dentaire.
DANGER: Contre-indiquée formellement sur tissu osseux ! **[Ref: Q3, Q7]**

Entrainement à air. Échauffement rapide exige un jet d'eau de refroidissement continu et obligatoire.

Micromoteurs



VITESSE: Sortie variable jusqu'à 40 000 tours/mn.
SENS DE ROTATION: Réversible. Choisi par l'opérateur.
FONCTION: Permet l'insertion des contre-angles et pièces à main. **[Ref: Q13]**

Actionnés par courant électrique ou air comprimé.

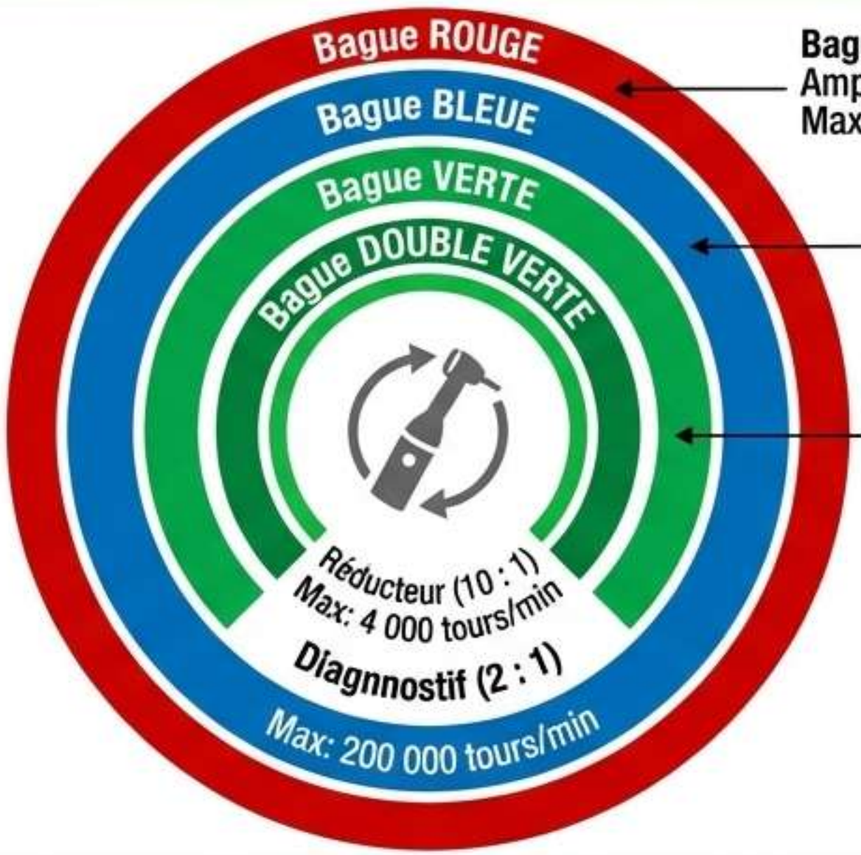
Dentist Web

Clinical Blueprint & Technical Atlas

Instrumentation Dynamique II : Contre-Angles et Séquenceurs

Entrainés par le micromoteur. Utilisés sur le tissu dentaire et sur l'os.

LA MATRICE DES CODES COULEURS [Predicted - Granular MCQ Data]



Bague ROUGE
Amplificateur (1 : 5)
Max: 200 000 tours/min

Bague BLEUE
Aucun effet (1 : 1)
Max: 40 000 tours/min

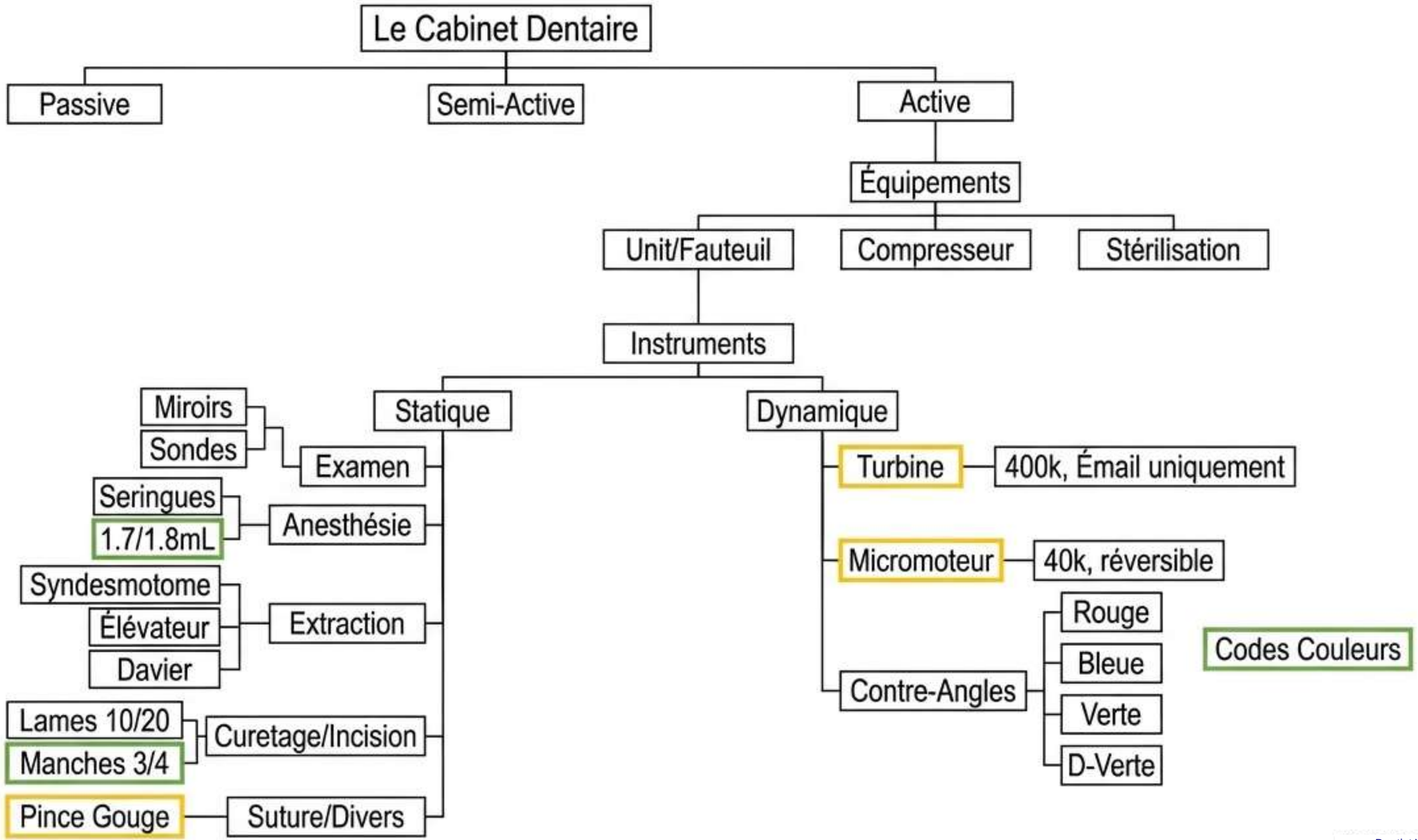
Bague VERTE
Réducteur (2 : 1)
Max: 20 000 tours/min

Séquenceurs (Jeu de fraises) : Tranchants, diverses tailles (boule, cylindrique), diamantés ou carbure de tungstène.
Usages: Trépanations osseuses et sectionnement.

Dentist Web

Clinical Blueprint & Technical Atlas

Synthèse Globale : L'Arbre Taxonomique Clinique



Dentist Web

PDF fully scanned.
100% content coverage confirmed.
No omission detected.

La maîtrise de ces dispositifs et de cette architecture rigoureuse garantit la sécurité absolue et l'efficacité de vos futurs actes cliniques.

Dentist Web